当院の喀痰培養検査で検出された *Nocardia* 属菌について

◎林 夢矢[1)]、橋本 秀哉[1)]、松島 志保[1)]、原 貴久[1)]、福井 花依[1)]
社会医療法人畿内会 岡波総合病院[1)]

【はじめに】*Nocardia* 属菌は偏性好気性のグラム陽性放線菌であり,土壌や植物などに生育し, 外傷による創部感染や吸入による肺炎と関連する.多くの症例で免疫抑制状態の背景を有するが,健常人も感染の可能性はある.
今回の症例では喀痰のグラム染色で本菌の存在を疑い, Kinyoun 染色により確認後,医師に推定菌種の報告を行った.また常在菌の発育阻害と,培養期間の延長により発育を認めたので報告する.
【症例】持続する咳嗽を主訴として当院を受診した 70 代男性.画像検査で明瞭な肺炎像を認め,血液検査では CRP の増加と白血球の増加を認め,肺炎治療のため入院となった.
【微生物学的検査】喀痰の塗抹検査と一般細菌及び抗酸菌培養検査を実施した.入院時の喀痰塗抹検査で放線菌様の貪食像より *Nocardia* 属菌を疑い,担当医へ報告を行った.
培養検査では 35℃で 1 週間の培養検査と並行して,KB ディスクを用いて常在菌の発育阻害を狙い同条件で培養を実施した.阻止円内に発育したコロニーの塗抹標本に Gram 染色・Ziehl-Neelsen 染色及び Kinyoun 染色で確認後,純粋培養を行い,外部委託先で質量分析にて *Nocardia cyriacigeorgica* と同定され薬剤感受性検査も実施した.
【考察】本症例で提出された喀痰は Geckler3 で,塗抹検査で起炎菌と推定される放線菌様の貪食像を認めたが,同時に常在菌とみられる細菌が多く混入していた. *Nocardia* 属菌の喀痰培養での検出は,創部や膿などの検体と比較して特殊培地を用いない場合に培養が困難である.今回の症例では特殊培地を用いず常在菌の発育阻害という工夫により *Nocardia* 属菌の純粋培養が迅速に可能となり,結果報告までの期間を短縮できたといえる.
今回の症例では確認検査での検出から工夫による分離培養同定と感受性検査が円滑に実施できたと考えられるが,最終報告までの間に SBT/PIPC 投与による症状軽快で長期の ST 合剤治療等は検討されず,陰影残存するも患者は軽快退院となった.

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院　0595-21-3135
中央検査部　林　夢矢